

Опыт Мурманской области в разделении потоков, перераспределении функций между врачами, медсёстрами и немедицинским персоналом

Доклад главного врача поликлиник №1, 2 г. Мурманска

Биджоева К. М.

Мурманская городская поликлиника №2

7 филиалов

856 посещений в смену

44 участка

94 414 прикреплённых пациентов

66 187 трудоспособного возраста

Кадры:

465 сотрудников

104 врача (укомплектованность 76,5%)

197 фельдшеров и медсестёр
(укомплектованность 92,3%)

В структуре:

3 терапевтических отделения

2 отделения врачей общей практики

Специализированное отделение

Хирургическое отделение

Отделение профилактики

Дневной стационар

Отделение неотложной медицинской
помощи

Колл-центр

...

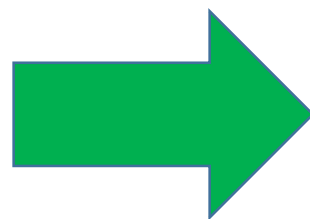
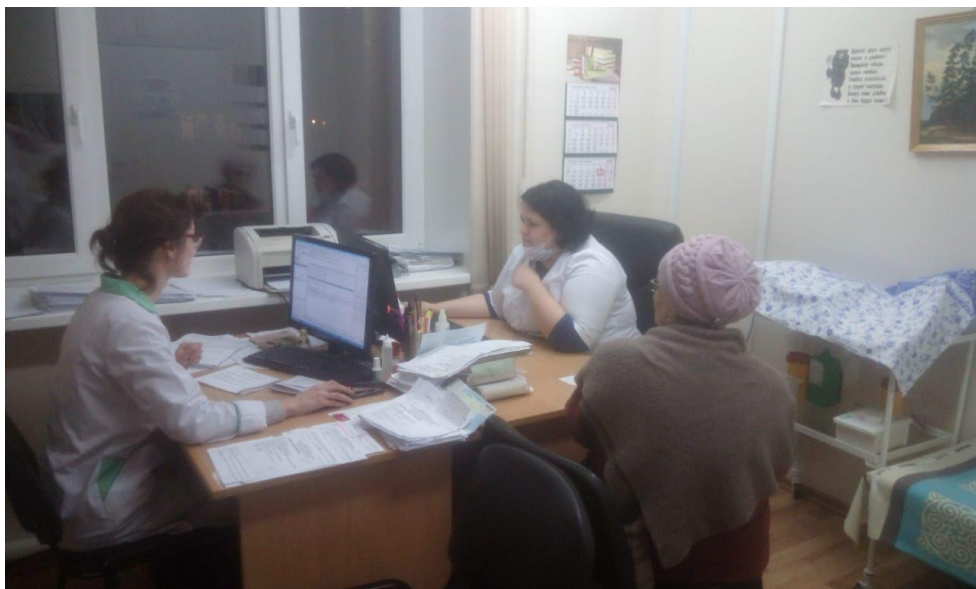
2016 год: изменения в поликлиниках Мурманской области



- Доброжелательная регистратура
- Первый колл-центр
(“нет” телефонам в регистратуре)
- Первые речевые модули
- Первые листы ожидания

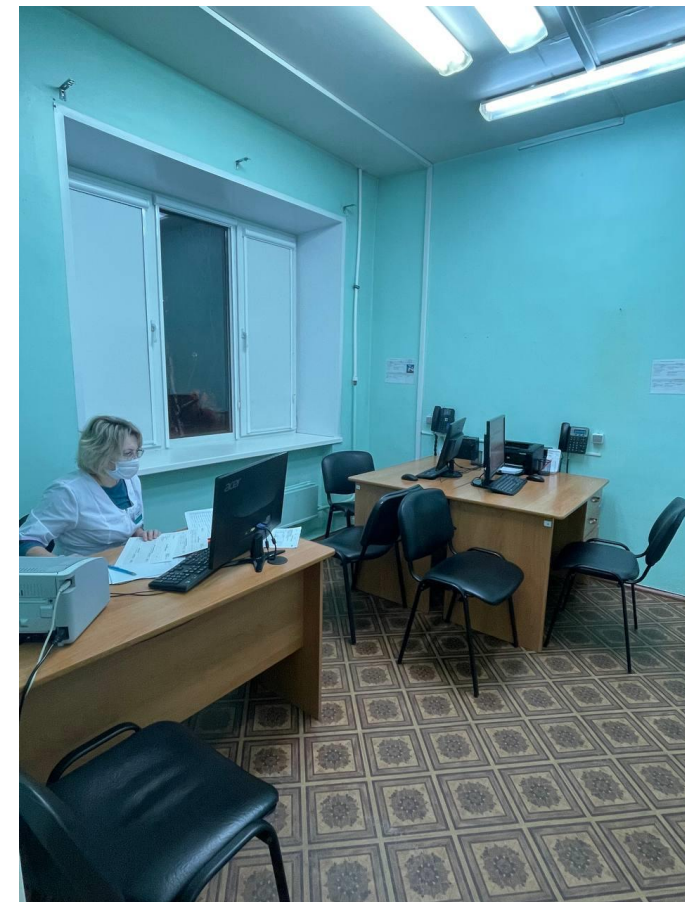
2017 год: следующий этап

- Организация сестринских постов
- Развитие отделений неотложной помощи



!Объединение поликлиник
Мурманска: 5 >> 2

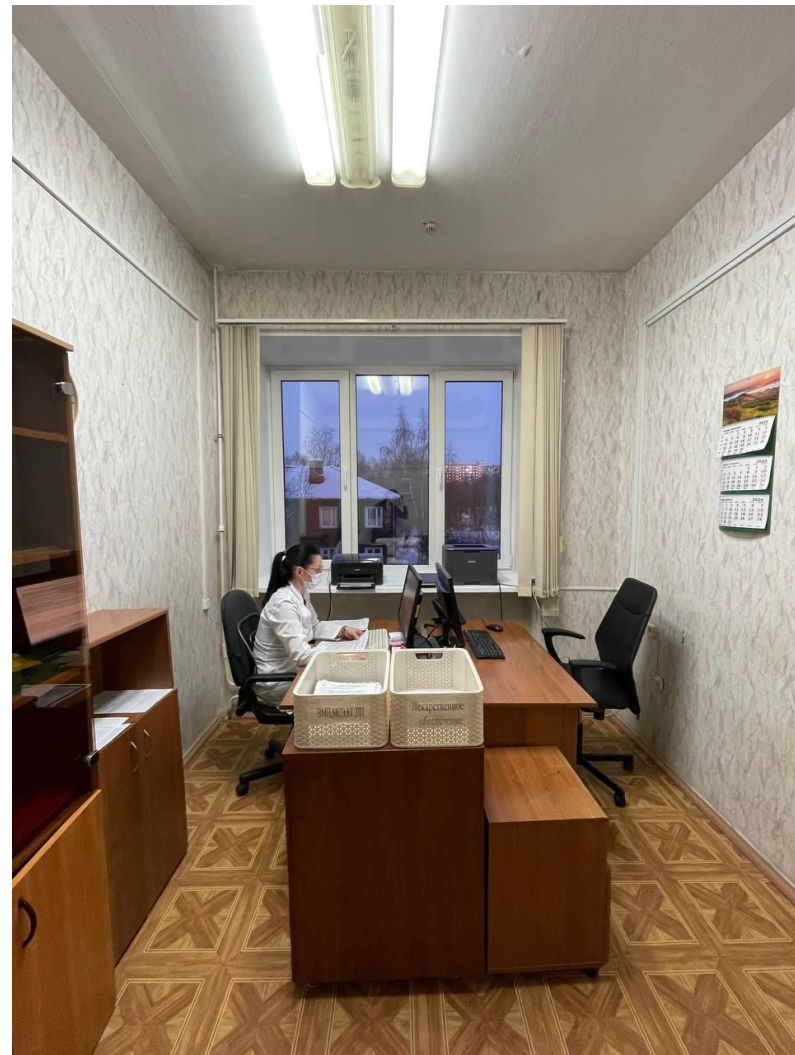
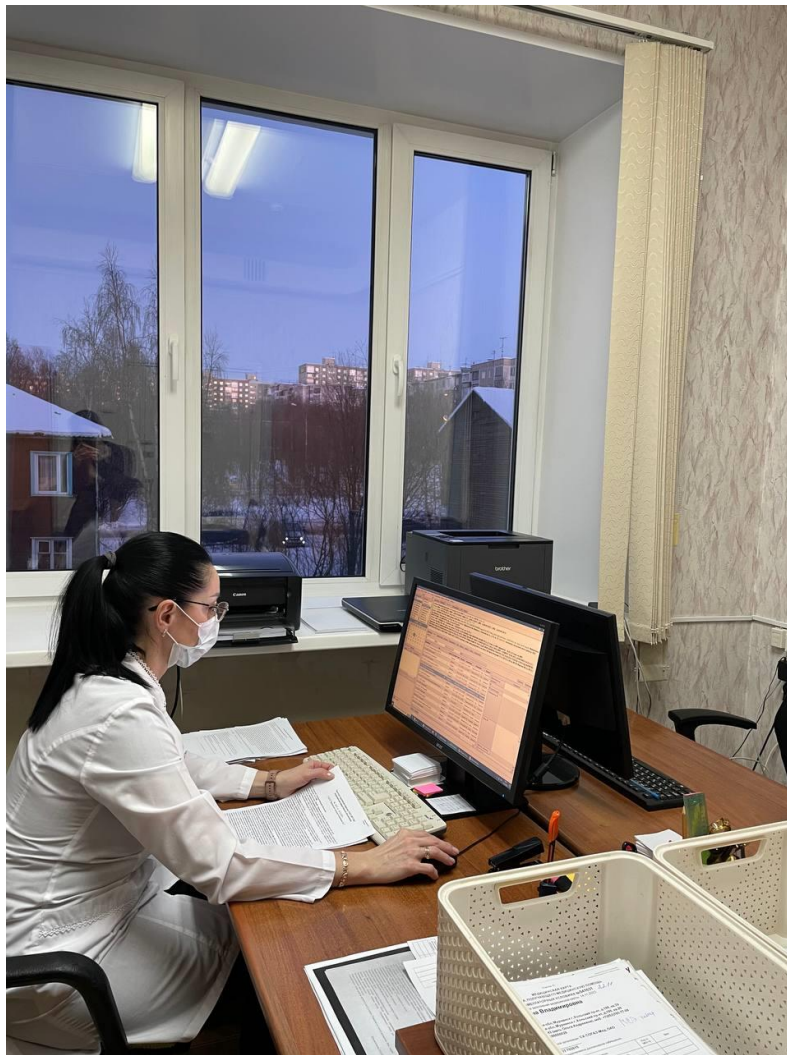
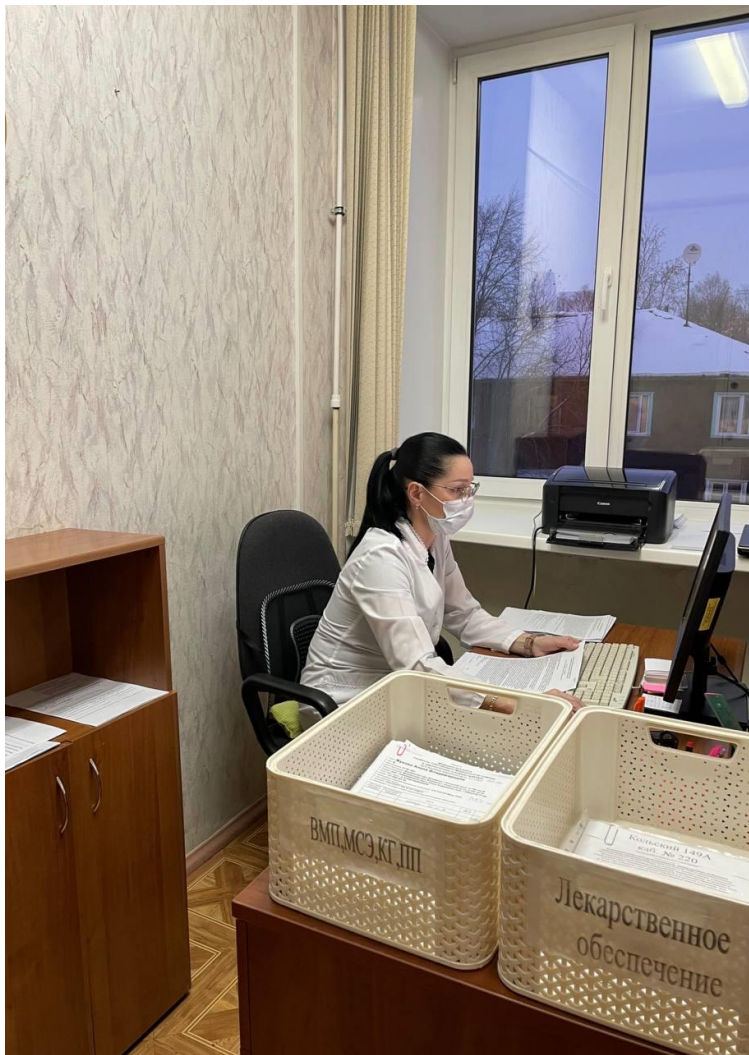
Сестринский пост



Сестринский пост



Кабинет оформления документов для МСЭ и ВМП

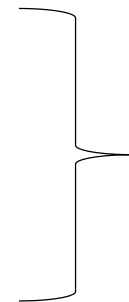


Кабинет оформления документов для МСЭ и ВМП

За 247 рабочих дней 2023 года во второй городской поликлинике оформлено:

790 форм 088/у-06

776 выписок для ВМП (СМП)



~6,3 документа
в день

Неотложная медицинская помощь

Отделение неотложной помощи

```
graph TD; A[Отделение неотложной помощи] --> B[Вызовы на дом]; A --> C[Кабинеты неотложной помощи]; A --> D[Кабинеты для пациентов с признаками ОРВИ];
```

Вызовы на дом

- Планшеты с мобильной версией МИС
- На пике подъема заболеваемости – только отдельные категории пациентов

Кабинеты неотложной помощи

- На первом этаже филиала
- Полная автономность
- Предварительная запись в день обращения на день обращения

Кабинеты для пациентов с признаками ОРВИ

- Отдельный вход
- Предварительная запись
- Отсутствие очередей

Отделение неотложной помощи

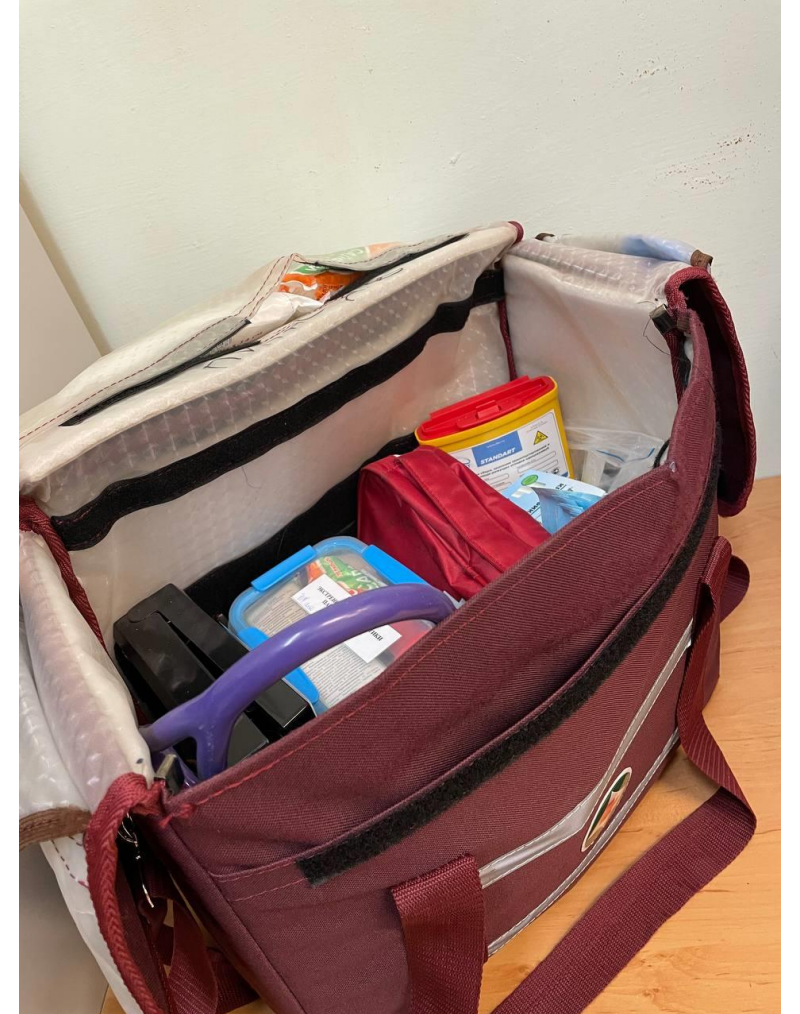
Заведующий отделением (врач)

Старший фельдшер

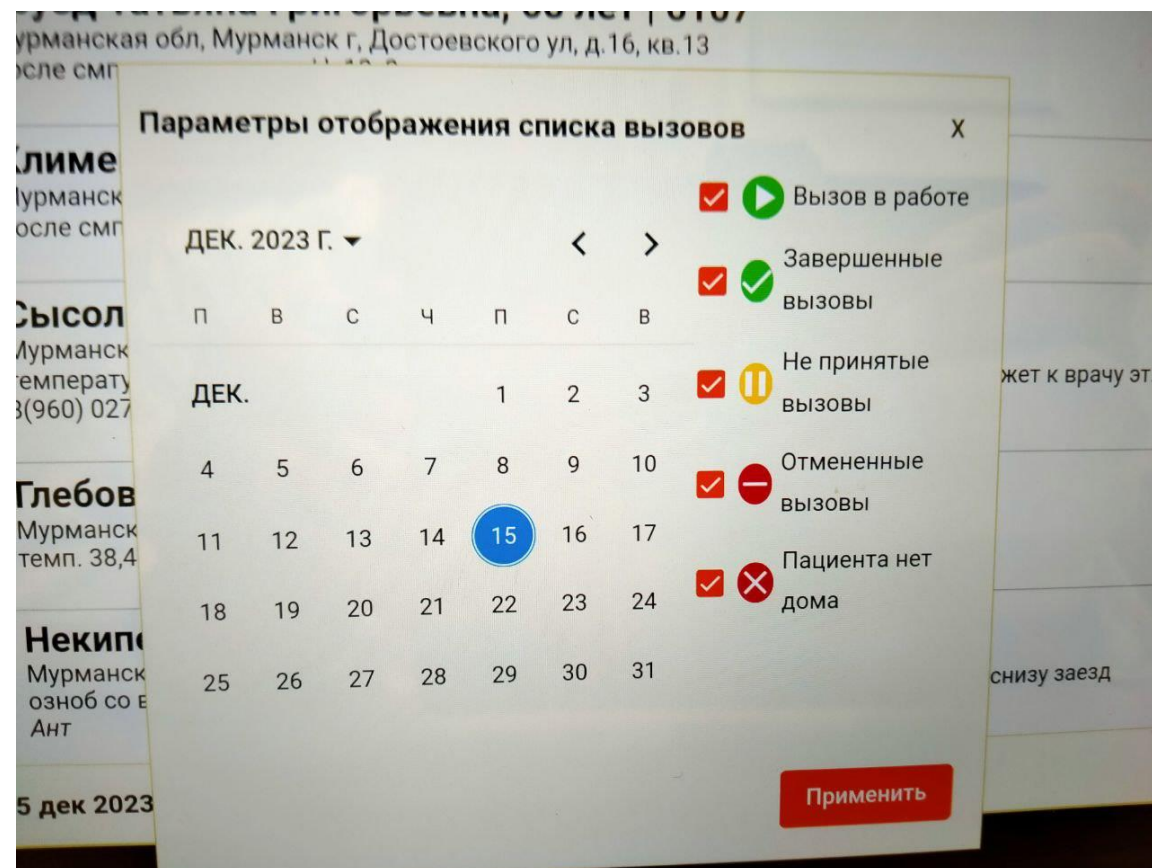
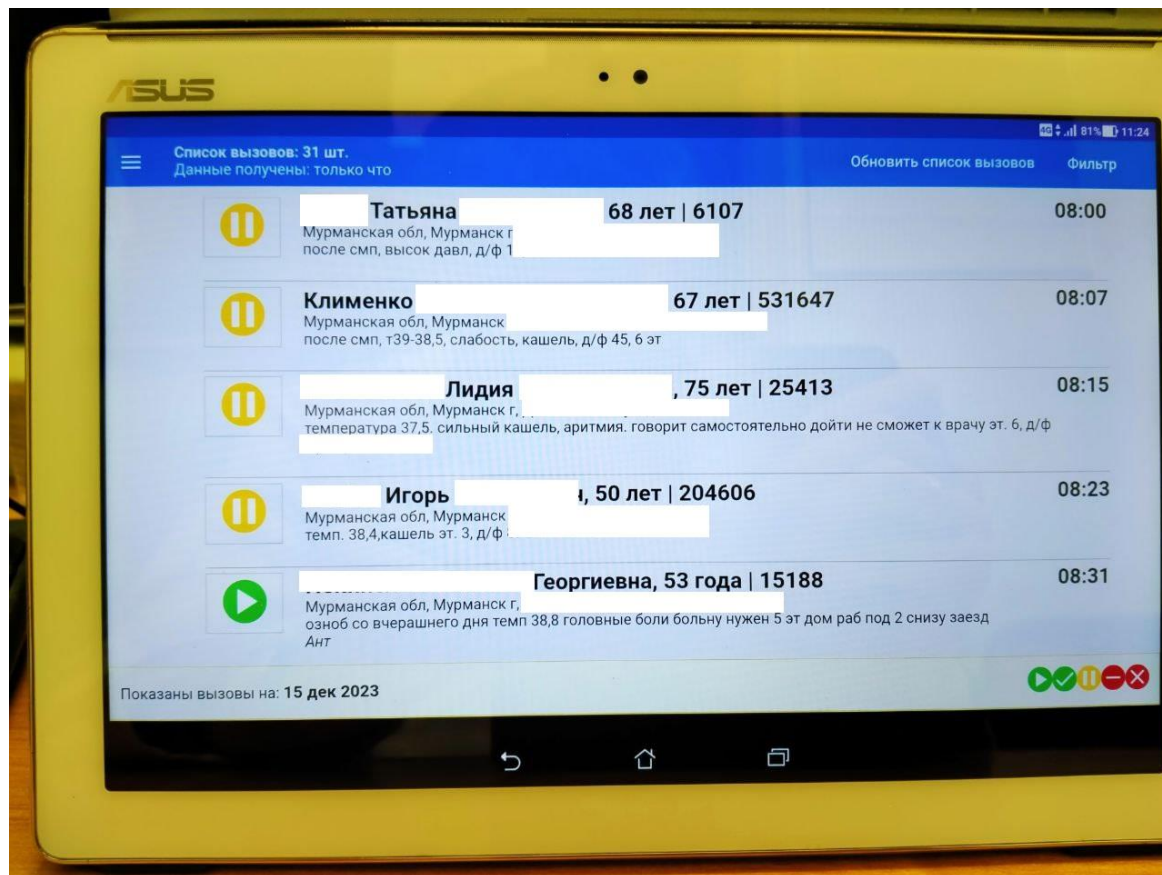
15 фельдшеров

*В составе отделения организованы кабинеты для выписки льготных рецептов – работают фельдшера

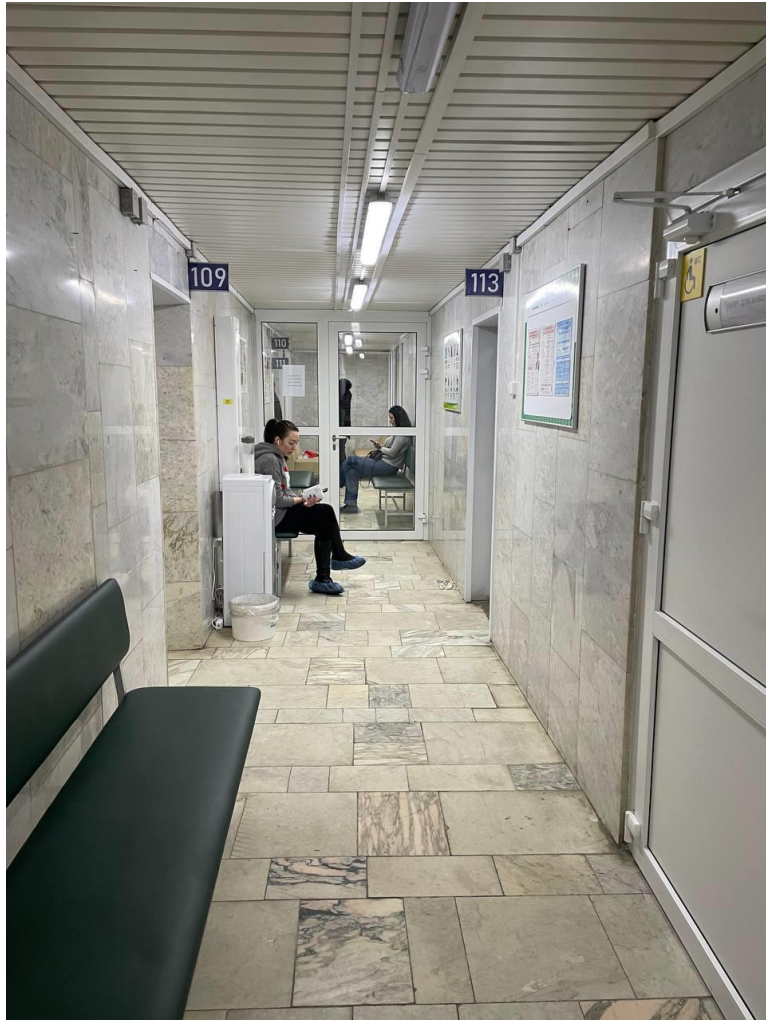
Неотложная медицинская помощь



Планшет фельдшера на выезде



Кабинет для пациентов с признаками ОРВИ



Нормативное регулирование на уровне поликлиники

Положение о работе отделения неотложной помощи Алгоритмы оказания неотложной медицинской помощи

О работе отделения неотложной медицинской помощи

Во исполнение Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 15 мая 2012 г. N 543н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению", с целью организации оказания неотложной медицинской помощи населению, **приказываю:**

1. Утвердить Положение об отделении неотложной медицинской помощи (приложение №1).
2. Заведующему отделением неотложной медицинской помощи: организовать работу отделения в соответствии с положением.
3. Признать утратившим силу приказ главного врача от 01.06.2017 №80 "Об организации отделения неотложной медицинской помощи взрослому населению".
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя главного врача по медицинской части.

Главный врач

К. М. Билалов

Об утверждении алгоритмов оказания медицинской помощи в поликлинике

С целью стандартизации подходов к оказанию неотложной медицинской помощи в поликлинике, повышению качества медицинской помощи, **приказываю:**

1. Утвердить перечень лекарственных средств и предметов медицинского назначения для оказания неотложной помощи пациентам на амбулаторном этапе (Приложение №1)
2. Утвердить перечень кабинетов, которые должны быть обеспечены укладками для оказания первичной медико-санитарной помощи взрослым в неотложной форме (далее - укладка) (Приложение №2)
3. Старшему фельдшеру отделения неотложной медицинской помощи:
 - 3.1. Актуализировать содержимое укладок в соответствии с прилагаемым перечнем (Приложение №1)
 - 3.2. Осуществлять ежемесячный контроль соответствия укладок стандарту, утверждённому настоящим приказом
4. Утвердить алгоритмы оказания неотложной медицинской помощи при отдельных состояниях и заболеваниях (Приложение №3)
5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя главного врача по медицинской части.

Главный врач

К. М. Билалов

Нормативное регулирование на уровне поликлиники

Алгоритмы оказания неотложной медицинской помощи

36. кетопрофен 50 мг/мл – 2,0 № 10
37. метамизол натрия 500 мг/мл – 2,0 № 10
38. метамизол натрия +питофенон+фенпивериния бромид 2 мл № 10
39. парацетамол 500 мг № 10
40. сальбутамол 100 мкг/доза – 200 доз
41. аминофиллин 2,4 % - 10,0 № 10
42. хлоропирамин 20 мг/мл – 1,0 № 5
43. вода для инъекций 2 мл № 10
44. бинт нестерильный 5*5 – 1 штука
45. бинт стерильный 5*10 – 1 штука
46. бинт стерильный 7*14 – 1 штука
47. вата – 1 упаковка
48. воздуховод Гведела – 2 штуки
49. жгут кровоостанавливающий 2 штуки
50. жгут для в/в инъекций – 1 штука
51. катетер для периферических вен – 6 штук
52. катетер уретральный мужской – 1 штука
53. лейкопластырь бактерицидный 1,9*7,2 см – 1 штука
54. пакет гипотермический – 1 штука
55. пакет перевязочный стерильный – 2 штуки
56. перчатки мед. нестерильные – 2 пары
57. перчатки хир. Стерильные – 2 пары
58. салфетка спиртовая- 2 штуки
59. средство стимуляции дыхания – 2 штуки
60. салфетка марлевая стерильная 16*14 № 10 – 1 упаковка

Бронхоастматический статус

Клиническая картина	Оказание помощи
В анамнезе: <u>установленный диагноз бронхиальной астмы</u>, развитию статуса способствуют <u>передозировка ингаляционных бета2-агонистов</u>. Приступ удушья на фоне тотального бронхоспазма или тотальной бронхообструкции («немое легкое»), <u>прекращение отделения мокроты, резистентность к бета2-агонистам</u>; гипоксия, проявляющаяся одышкой и цианозом; Оценка степени тяжести статуса: I стадия: относительная компенсация, трансформация затянувшегося приступа в статус: многократные приступы удушья, экспираторная одышка, неэффективность бронхолитиков, вынужденное положение, участие вспомогательной мускулатуры в акте дыхания, обилие сухих свистящих и разнокалиберных влажных хрипов, гипоксемия («бледный цианоз»); II стадия: «немое легкое», нарастающая дыхательная недостаточность вследствие тотального бронхоспазма, постоянное удушье, цианоз, выраженная одышка в покое, полное отсутствие хрипов при аускультации; III стадия: гипоксическая кома, приводящая к смерти.	преднизолон 60-90 мг в разведении 6,0 мл. воды для инъекций в/в струйно; эуфиллин 2,4%-10,0 в разведении 10,0 мл. воды для инъекций в/в струйно; ЭКГ контроль, пульсоксиметрия, контроль ЧДД, АД; Срочный вызов СМП; Госпитализация!
Вызвать бригаду скорой медицинской помощи	

Нормативное регулирование на уровне поликлиники

Приказ о записи на приём к врачу и о перераспределении функций

Приложение №4
к приказу ГБУЗ «Мурманская
городская поликлиника №2»
от 24.11.2023 № 97

Схемы перераспределения функций врача участкового (врача-терапевта участкового, врача общей практики (семейного врача) согласно действующему законодательству

- I. Перераспределение функций участкового врача
1. 9 функций участкового врача:
 - 1.1. Диагностика заболеваний
 - 1.2. Назначение лекарственных препаратов
 - 1.3. Работа в составе врачебной комиссии
 - 1.4. Назначение мероприятий по уходу за пациентом
 - 1.5. Разработка программы оздоровительных мероприятий
 - 1.6. Направление пациента к врачам-специалистам
 - 1.7. Проведение экспертизы временной нетрудоспособности
 - 1.8. Направление на МСЭ
 - 1.9. Организация медицинской реабилитации
2. 13 функций, распределённых между участковым врачом и персоналом со средним медицинским образованием:
 - 2.1. Оформление рецептурного бланка, санаторно-курортной карты, справок, направлений на МСЭ
 - 2.2. Проведение медицинских осмотров: профилактических, периодических
 - 2.3. Диспансерное наблюдение
 - 2.4. Определение медицинских показаний к введению ограничительных мероприятий (карантина)
 - 2.5. Оценка эффективности и безопасности применения медикаментозных и немедикаментозных методов лечения
3. 3 функции участкового врача, передаваемые персоналу со средним медицинским образованием:
 - 3.1. Подготовка списков для диспансерного наблюдения
 - 3.2. Проведение санитарно-гигиенического просвещения населения
 - 3.3. Оказание медицинской помощи в несложной форме на дому
4. 2 функции участкового врача, передаваемые персоналу без медицинского образования:
 - 4.1. Ведение персонального учёта, информационной базы данных состояния здоровья населения
 - 4.2. Ведение паспорта врачебного участка
5. 1 функция, распределённая между участковым врачом, персоналом со средним медицинским образованием и персоналом без медицинского образования: организация и проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни.
- II. Перераспределение функций персонала со средним медицинским образованием
1. 10 функций, распределённых между врачом-терапевтом и персоналом со средним медицинским образованием:
 - 1.1. Определение показаний к введению ограничительных мероприятий
 - 1.2. Проведение иммунизации населения
 - 1.3. Контроль проведения профилактических мероприятий
 - 1.4. Участие в проведении медицинских осмотров
 - 1.5. Диспансерное наблюдение за состоянием здоровья лиц, страдающих хроническими заболеваниями
 - 1.6. Проведение диспансеризации населения
 - 1.7. Направление пациента на лабораторное и инструментальное обследование
 - 1.8. Оценка эффективности и безопасности медикаментозного и

Мурманская городская поликлиника №1

10 филиалов

1 333 посещений в смену

65 участков

116 030 прикреплённых пациентов

93 459 трудоспособного возраста

Кадры:

524 сотрудника

119 врачей (укомплектованность 96,6%)

223 фельдшеров и медсестёр (укомплектованность 91,1%)

В структуре:

Отделение первичной специализированной медико-санитарной помощи №5:

*Кабинет паллиативной медицинской помощи

*Выездная патронажная паллиативная бригада

*Кабинет врача-гериатра

*Кабинет профилактики и лечения остеопороза

*Кабинет нарушения памяти

***Кабинет медико-социальной помощи**

Кабинет медико-социальной помощи (маломобильным пациентам на дому)

«Поликлиника на дому»: в один визит: осмотр врача/фельдшера, забор биологического материала, инструментальное обследование, выписка рецептов, доврачебная помощь.

Сокращение времени оформления и направления **документов на МСЭ** до 30-ти дней.

Взаимодействие с соцслужбами.

Кадры:

3 фельдшера

2 медсестры

**В 2023 году осмотрено 807
маломобильных пациентов на дому!**

- Профилактические осмотры
- Диспансерное наблюдение
- Вакцинация

Проблемы и задачи

- ✓ **Поддержание уровня достигнутых улучшений**
- ✓ **Недопущение “отката к заводским настройкам”**